MANUAL DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL

Adaptación realizada por el prof. Tomás Jesús Carrasco Giménez del protocolo propuesto por:

Lejuez, C. W., Hopko, D. R., LaPage, J. P., Hopko, S. D., y McNeil, D. W. (2001). A brief Behavioral Activation Treatment for Depression. *Cognitive and Behavioral Practice, 8,* 164-175.

Lejuez, C. W., Hopko, D. R., y Hopko, S. D. (2001). A Brief Behavioral Activation Treatment for Depression: Treatment Manual. *Behavior Modification, 25,* 255-286.

BASE TEÓRICA

La depresión se mantiene porque:

1. la conducta no depresiva recibe poco o ningún reforzamiento,
2. la conducta no depresiva recibe reforzamiento muy demorado,
3. la conducta depresiva recibe una gran cantidad de reforzamiento (atención por parte de otros, evitación de obligaciones).
4. una combinación de estos factores.

Por tanto, el objetivo de tratamiento de la depresión debe ser incrementar el reforzamiento inmediato de la conducta no depresiva y disminuir el reforzamiento de la conducta depresiva.

Para ello se adoptan dos medidas principales:

- incrementar gradualmente el número, frecuencia y duración de un conjunto de actividades previamente seleccionadas para acrecentar la exposición a las consecuencias positivas que depara su realización,
- pactar con las personas con las que convive el paciente que retiren el reforzamiento (positivo o negativo) que proporcionan a la conducta depresiva de este.

Se considera que los comportamientos cognitivos ("pensamientos negativos", "creencias irracionales", etc) desaparecerán sin necesidad de intervenir directamente sobre ellos.

CONTRATO CONDUCTUAL
Yo _____ intentaré evitar la realización de la conducta/s no saludable _____ _____ Si realizo dicha conducta _____ está de acuerdo con evitar recompensarla con _____ _____ En su lugar, trataré de realizar las siguiente conductas saludables: _____ _____ Si las llevo a cabo _____ está conforme con recompensarme con _____ Firma

PROCEDIMIENTO

Es fundamental, al comienzo de la intervención, establecer una excelente relación terapéutica con el/la paciente.

1. Identificar las conductas depresivas que realiza el paciente y los reforzadores positivos y negativos a los que accede llevándolas a cabo.

2. En el caso de que se descubra que la conducta depresiva recibe reforzamiento por parte de personas cercanas al paciente, se establecen contratos conductuales con dichas personas para que consignen su compromiso a dejar de proporcionar dicho reforzamiento.

Los autores sugieren no aplicar una extinción total a la conducta verbal depresiva del paciente, ya que es razonable que cualquier persona necesite hablar con otras sobre sus problemas y dificultades. Proponen que el terapeuta acuerde con el paciente y con las personas de su entorno que se dedique como máximo un 25% del tiempo que dure una interacción a hablar sobre problemas o preocupaciones del paciente.

3. Se encarga al paciente un registro de actividad diario durante una semana.

Con la realización de este autoregistro se persiguen dos objetivos:

- Obtener una línea base para comparar después el progreso conseguido con la terapia.

- Si es el caso, facilitar que el paciente tome conciencia de que su nivel real de actividad es menor de lo que él/ella cree. Aumentar con ello su motivación para incrementar su nivel de actividad.

Es muy importante insistir al paciente acerca de la importancia de realizar las tareas para casa que se le encarguen, explicándole que el éxito de la terapia depende, sobre todo, de su constancia en llevarlas a cabo.

REGISTRO DE ACTIVIDAD DIARIA

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
6 - 7							
7 - 8							
8 - 9							
9 - 10							
10 - 11							
11 - 12							
12 - 13							
13 - 14							
14 - 15							
15 - 16							
16 - 17							
17 - 18							
18 - 19							
19 - 20							
20 - 21							
21 - 22							

REGISTRO DE ACTIVIDAD DIARIA

	Lunes	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**Domingo**
22 - 23							
23 - 24							
24 - 1							
1 - 2							
2 - 3							
3 - 4							
5 - 6							

4. Identificar actividades deparadoras de reforzamiento y organizarlas en una jerarquía.

Para facilitar la identificación de potenciales actividades reforzantes estos autores sugieren, en primer lugar, invitar al paciente a reflexionar sobre diferentes facetas de su vida, siguiendo una propuesta de Hayes, S. C., Strosahl, K. D., y Wilson, K. G. (1999). *Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change*. Nueva York: Guilford.

1. *Relaciones familiares:* por ejemplo, ¿qué tipo de hermano/a, hijo/a, padre/madre quieres ser? ¿qué cualidades son importantes en tu relación con los miembros de tu familia?

2. *Relaciones sociales:* por ejemplo, ¿cómo sería para ti una relación de amistad ideal? ¿qué aspectos de la relación con tus amigos podrían mejorar?

3. *Relaciones íntimas:* por ejemplo, ¿cómo te gustaría comportarte en una relación íntima? ¿mantienes ahora este tipo de relación, o te gustaría establecerla?

4. *Educación/formación:* por ejemplo, ¿te gustaría continuar estudiando o recibir una formación especializada? ¿te gustaría informarte más sobre esta posibilidad?

5. *Trabajo/carrera profesional:* por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo te gustaría tener? ¿qué tipo de trabajador te gustaría ser?

6. *Aficiones/recreación:* por ejemplo, ¿tienes intereses que te gustaría explorar, o nuevas actividades que te apetecería probar?

7. *Trabajo voluntario/caridad/actividades políticas:* por ejemplo, ¿qué contribuciones te gustaría realizar a la comunidad?

8. *Condición física/salud:* por ejemplo, ¿quieres mejorar tu dieta, sueño, ejercicio, etc?

9. *Espiritualidad:* por ejemplo, ¿qué significa para ti, si significa algo, la espiritualidad? ¿estás satisfecho/a con esta área de tu vida?

10. *Temas emocionales/psicológicos:* por ejemplo, ¿qué te gustaría conseguir con este tratamiento? ¿aparte de la depresión, hay algunos otros temas que te gustaría explorar?

A continuación, para ayudar al paciente a identificar actividades concretas, sugieren presentarle el PES (McPhillamy, C., y Lewinsohn, P. M. (1971). *The Pleasant Events Schedule*. Eugene: University of Oregon).

Seguidamente, se pide al paciente que prepare una lista que recoja las actividades seleccionadas agrupadas según las áreas anteriormente señaladas.

Evaluación de las áreas vitales
Describe las actividades que te gustaría llevar a cabo en cada una de estas áreas: 1. Relaciones familiares: 2. Relaciones sociales: 3. Relaciones íntimas: 4. Educación/formación: 5. Trabajo/carrera profesional: 6. Aficiones/recreación: 7. Trabajo voluntario/caridad/actividades políticas: 8. Condición física/salud: 9. Espiritualidad: 10. Temas emocionales/psicológicos:

A la hora de describir actividades es muy importante ayudar al paciente para llegar a definirlas en términos operacionales, es decir, tienen que estar definidas de tal forma que sean observables por otros y medibles. Por ejemplo, "pensar positivamente" no constituye una definición satisfactoria de actividad. Si lo es "visitar a mi hermana dos veces a la semana".

Así mismo, en el caso de que el paciente escoja un objetivo a largo plazo es necesario describir todas las actividades previas necesarias para poder alcanzarlo. Por ejemplo, si elige "conseguir una relación más estrecha con un miembro de su familia" las actividades previas necesarias para lograrlo serían pasar más tiempo juntos, compartir actividades gratificantes, ofrecerse como canguro o comenzar a recibir, de mutuo acuerdo, asesoramiento familiar, etc[1].

En ocasiones los pacientes seleccionan actividades muy difíciles de realizar y cuyos beneficios son muy demorados o inciertos. Los autores aconsejan permitir que el paciente formule este tipo de objetivos muy difíciles y a largo plazo "para no limitar su ambición", pero sugieren animar al paciente a seleccionar actividades de variada dificultad, incluyendo sólo unos pocos objetivos de este tipo.

En total, los autores proponen que se confeccione una lista con quince actividades.

Una vez confeccionada la lista, se pide al paciente que la traslade a un cuadro como el que figura a continuación y valore la dificultad que implicaría la realización de cada una de ellas (asignando 1 a la más fácil y 15 a la más difícil).

Seguidamente, se le solicita que anote las actividades en otra lista agrupándolas en cinco categorías según el grado de dificultad que implica su realización.

En el nivel 1 se deberían incluir solamente actividades que el paciente ya esté llevando a cabo en alguna medida pero que le gustaría realizar con mayor frecuencia. Para identificarlas se recurriría al Diario de Actividad. Por ejemplo, si el paciente se levanta antes de las nueve de la mañana un día a la semana, pero le gustaría hacerlo más a menudo, ese objetivo podría incluirse en el primer nivel.

1[1]Se pueden plantear varias objeciones a esta propuesta. En primer lugar, no resulta claro de qué forma la invitación a reflexionar sobre diferentes áreas de la vida puede facilitar la identificación de actividades "gratificantes". Dicha reflexión propicia, más bien, que el paciente formule "objetivos a largo plazo" que le gustaría alcanzar, más que la identificación de actividades concretas que le puedan resultar reforzantes. Por otra parte, las actividades intermedias que requerirá la consecución de dichos objetivos pueden no facilitar la exposición a reforzadores, por ejemplo, "hacer de canguro" en el caso presentado por los autores.

HOJA PARA ORDENAR LAS ACTIVIDADES SEGÚN SU DIFICULTAD

Actividad	Dificultad

JERARQUÍA DE ACTIVIDADES

NIVEL UNO

A.

B.

C.

NIVEL DOS

A.

B.

C.

NIVEL TRES

A.

B.

C.

NIVEL CUATRO

A.

B.

C.

NIVEL CINCO

A.

B.

C.

El paso siguiente consiste en establecer cuáles serán las actividades que realizará el paciente durante la próxima semana. Los autores sugieren que para la primera semana se escojan dos o tres actividades y para las posteriores entre tres y cinco. Trabajando conjuntamente paciente y terapeuta establecen, para cada una de las actividades, la meta final que se desea alcanzar, en términos de frecuencia semanal de realización, y la frecuencia que se propone como objetivo para la semana siguiente. Y trasladan todo esto a un registro semanal denominado "Registro de Actividad Maestro". El proceso, detallado, sería el siguiente: en la primera columna de dicho registro se recoge la jerarquía de actividades. En la columna siguiente, junto a cada actividad, se hace constar la frecuencia y duración semanal ideal (si no procede precisar una duración determinada, se escribe IN ("indeterminada"). En la columna que figura a continuación, paciente y terapeuta decidirán conjuntamente, para las actividades escogidas para realizar esa semana, su frecuencia y duración. Tanto el terapeuta como el paciente guardarán una copia de este registro.

Además de este registro, el terapeuta solicitará al paciente que cumplimente cada día un registro de actividad: el "Registro Comportamental". Cada día, preferiblemente a una hora fija acordada previamente (por ejemplo, justo antes de acostarse), el paciente anotará (rodeando con un círculo la S o la N) si ha realizado o no las actividades que ha pactado con la terapeuta para esa semana. Si un día no ha llevado a cabo la actividad establecida pero ya ha alcanzado el objetivo fijado para esa semana respecto a dicha actividad, el paciente rodeará con un círculo la letra M ("meta").

Los autores consideran que este registro resulta muy útil porque:

- permite evaluar los progresos del paciente,

- facilita que rodear con un círculo la S se convierta en un reforzador condicionado al ser asociado con la felicitación proporcionada por la terapeuta,

- rodear con un círculo la letra M, además de convertirse en un reforzador condicionado, propicia que el paciente aprenda que el objetivo perseguido no es la perfección, es decir, que el paciente realice todas las actividades todos los días, sino alcanzar y mantener metas razonables. Además evita que el paciente se sienta culpable si un día no realiza alguna de las actividades propuestas cuando ya haya cubierto el objetivo propuesto para esa semana (la terapeuta debería indicar expresamente esto último al paciente).

REGISTRO DE ACTIVIDAD MAESTRO

Actividad	Meta ideal		Semana ___			Semana ___			Semana ___			Semana ___		
	F	D	F	D	(	F	D	(	F	D	(	F	D	(

REGISTRO COMPORTAMENTAL

Actividad	F	D	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
			S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N

Al finalizar la semana, el paciente debe anotar en la columna (del "Registro de Actividad Maestro"el número de veces que ha realizado (con la duración establecida) durante esa semana cada una de las actividades programadas, tal y como consta en el "Registro Comportamental".

Al comienzo de cada sesión, la terapeuta examina el "Registro Comportamental" y el "Registro de Actividad Maestro" y refuerza verbalmente al paciente por los resultados obtenidos.

Respecto a aquellos objetivos que el paciente alcance (o sobrepase), la terapeuta y el paciente pueden plantearse, de cara a la siguiente semana, incrementar la frecuencia y/o duración propuesta como objetivo (si todavía no se ha alcanzado la meta ideal.

En relación a las actividades que no se hayan realizado con la frecuencia prevista, la terapeuta y el paciente deben determinar si el objetivo planteado era razonable y no se ha alcanzado por razones de fuerza mayor o si, por el contrario, no era razonable o excesivo. En el primer caso, se propone para la semana siguiente el mismo objetivo y en el segundo se reduce o se considera abandonarlo y sustituirlo por otro.

Cuando el paciente logra durante tres semanas consecutivas un objetivo semanal que coincide ya con la meta ideal, se considera ese objetivo como superado. A partir de ese momento dicha actividad no se incluye en el registro comportamental, y se escribe SU en las columnas correspondientes a la "meta ideal" del registro de actividad maestro.

En principio, cada vez que el paciente supera un objetivo se añade una nueva actividad, aunque este ritmo de avance puede ser más rápido o más lento dependiendo de las circunstancias de cada paciente.

Por otra parte, se propone al paciente que se conceda reforzadores por la consecución de los objetivos propuestos para cada semana. Se le invita a seleccionar un conjunto de reforzadores entre los que no pueden figurar actividades incluidas en la lista de actividades sobre la que se está trabajando. Cada semana el paciente escoge un reforzador al que accederá si cumple los objetivos propuestos para la semana siguiente.

Finalmente, los autores plantean que con algunos pacientes (no especifican con cuáles) resulta útil elaborar gráficos que reflejen sus progresos, y sugieren, para ello, administrar semanalmente el BDI-II y anotar la puntuación en un gráfico y también recoger en un gráfico el incremento en el número de actividades realizadas.

LISTA DE RECOMPENSAS

Recompensas que puedo conseguir cumpliendo los objetivos semanales:

Semana	Recompensa elegida	Conseguida
		S N
		S N
		S N
		S N
		S N
		S N
		S N
		S N
		S N

63														
61 - 62														
59 - 60														
57 - 58														
55 - 56														
53 - 54														
51 - 52														
49 - 50														
47 - 48														
45 - 46														
43 - 44														
41 - 42														
39 - 40														
37 - 38														
35 - 36														
33 - 34														

31 - 32															
29 - 30															
27 - 28															
25 - 26															
23 - 24															
21 - 22															
19 - 20															
17 - 18															
15 - 16															
13 - 14															
11 - 12															
9 - 10															
7 - 8															
5 - 6															
3 - 4															
1 - 2															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

63															
61 - 62															
59 - 60															
57 - 58															
55 - 56															
53 - 54															
51 - 52															
49 - 50															
47 - 48															
45 - 46															
43 - 44															
41 - 42															
39 - 40															
37 - 38															
35 - 36															
33 - 34															
31 - 32															

29 - 30															
27 - 28															
25 - 26															
23 - 24															
21 - 22															
19 - 20															
17 - 18															
15 - 16															
13 - 14															
11 - 12															
9 - 10															
7 - 8															
5 - 6															
3 - 4															
1 - 2															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

LISTA DE ACTIVIDADES

Excursiones / salidas	T	**Entretenimiento**	T
Hacer un viaje		Ver la televisión o escuchar la radio	
Ir a una feria, al carnaval, al circo, a un zoo o a un parque de atracciones		Jugar al bingo, a la lotería, a las máquinas recreativas	
Ir a la playa		Ir al cine	
Ir de pic-nick		Ir a conciertos	
Salir a cenar fuera		Ir a las carreras (de caballos, coches, etc)	
Dar una vuelta en coche		Ir a un musical, a un espectáculo cómico	
Volar en un aeroplano, globo aerostático o helicóptero		Acudir a un evento deportivo	
Alojarme en un hotel		Otro:	
Ir de camping		**Deportes y juegos**	T
Visitar un museo o una exposición		Nadar, practicar esnórkel, buceo	
Ir de compras, ir de rebajas, ir a un rastro		Montar en bicicleta, patinar	
Ir a una biblioteca o librería		Cazar, tiro deportivo	

Salir del país		Practicar deportes de hierba (bádminton, criquet, petanca)	
Otro:		Correr o andar	
Interacciones con otros o actividades sociales	T	Tenis, padel, tenis de mesa, pelota mano, squash	
Ir u organizar una fiesta		Golf o mini golf	
Dar y recibir gestos físicos de cariño		Pescar	
Recordar, hablar sobre el pasado		Observar aves	
Actividades en grupo		Juegos de mesa	
Mantener una conversación franca o abierta		Juegos de cartas	
Estar con amigos		Hacer puzzles, crucigramas, rompecabezas	
Discutir sobre un tema de interés (deportes, noticias, moda, política)		Practicar la escalada	
Recibir la visita de un familiar o visitar a un familiar		Montar en canoa, en kayak, etc.	
Conocer a alguien		Jugar al billar	
Comer fuera con amigos o socios		Juegos de ordenador	
Visitar a un amigo o recibir la visita de una amigo		Otro:	
Otro:			

LISTA DE ACTIVIDADES II

Educación	T	**Aficiones, manualidades y actividades artísticas**	T
Aprender algo nuevo (un idioma, a tocar un instrumento musical, etc)		Tocar un instrumento musical	
Aprender algo artístico (pintar, alfarería, hacer croché, etc)		Cantar	
Leer		Bailar	
Asistir a un curso sobre algo que me interese		Manualidades y trabajo artísticos (dibujar, pintar, esculpir, alfarería, hacer películas)	
Escribir historias, novelas, poesía, ensayos, informes, etc		Labores de costura (hacer punto, croché, bordar	
Leer un libro o artículo sobre “cómo hacer...”		Restaurar antigüedades o cambiar el aspecto de muebles	
Acudir a una conferencia o charla de interés		Fotografía	
Volver a la escuela		Carpintería o ebanistería	
Asistir a un curso sobre ordenadores		Coleccionar cosas	
Otro:		Otro:	

Actividades domésticas	T	**Salud y apariencia**	T
Limpiar la casa		Hacerme fotografías	
Cocinar		Comprarme ropa, zapatos o abalorios	
Arreglar el césped, jardinería, diseñar jardines		Maquillarme o ir a una maquilladora	
Lavar el coche		Ir a la peluquería	
Costura		Hacerme la manicura o la pedicura	
Eximirme de realizar alguna tarea doméstica		Que me den un masaje	
Comprar flores o plantas		Ponerme perfume o colonia	
Reordenar o redecorar una habitación de la casa		Prepararme para salir	
Refrescar la casa con popurrí		Hacer algo para mejorar mi salud (arreglarme los dientes, cambiar de gafas, usar lentillas, comer de forma más saludable, empezar a hacer ejercicio)	
Hacer arreglos en la casa o trabajar en el coche		Cambiar de imagen, cambiar mi aspecto	
Otro:		Hacerme un chequeo	
		Otro:	